

Efeitos da musicoterapia no climatério e menopausa: uma revisão integrativa

*Effects of music therapy during climacteric and menopause:
an integrative review*

*Efectos de la musicoterapia en el climaterio y la
menopausia:
una revisión integrativa*

Lucila Garcia Matsumoto¹, Michele Barros de Souza Simões²,
Luciane Bizari Coin de Carvalho³

1. Pedagoga, Pós-graduada em Arteterapia, Pós-graduanda em Musicoterapia pela Faculdade Santa Marcelina, São Paulo-SP, Brasil. Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4445-4904>.

2. Musicoterapeuta, Especialista em Terapia Sistêmica Familiar, Mestranda em ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), São Paulo-SP, Brasil. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9904-7073>

3. Psicóloga, Doutora. Professora e Orientadora do curso de Pós-Graduação em Musicoterapia Aplicada da Faculdade Santa Marcelina, São Paulo-SP, Brasil. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1733-3023>

Resumo

Introdução. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, marcada por sintomas físicos e emocionais que afetam e comprometem a qualidade de vida, saúde integral, relacionamentos interpessoais e atividades diárias. Estratégias como a musicoterapia vêm sendo exploradas como forma de cuidado integrativo para promover bem-estar nesse período.

Objetivo. Verificar a aplicação da musicoterapia como intervenção para alívio dos sintomas na menopausa e climatério por meio de revisão bibliográfica. **Método.** Revisão Integrativa da Literatura nas bases Medline, Lilacs, Cochrane, SciELO e Google Scholar, com recorte de 2018 a 2025. Foram incluídos estudos com uso de música em mulheres no climatério e menopausa, abordando sintomas físicos, psicológicos e cognitivos. **Resultados.** Dos artigos encontrados, seis artigos foram selecionados: cinco utilizaram intervenção de escuta musical conduzida por profissionais da enfermagem e um abordou intervenções ativas e receptivas conduzidas por musicoterapeuta. As intervenções demonstraram efeitos positivos sobre a ansiedade, a insônia e a depressão. **Conclusão.** A revisão confirma que a musicoterapia pode ser uma intervenção eficaz para o alívio de sintomas no climatério e na menopausa, além de proporcionar um espaço de acolhimento e escuta para esse momento. A escuta musical realizada por outros profissionais mostrou benefícios relevantes, enquanto a atuação do musicoterapeuta ampliou as possibilidades terapêuticas ao favorecer o engajamento emocional e a expressão individual. A prática, portanto, mostra-se promissora no cuidado integral à mulher nesta fase.

Unitermos. Menopausa; climatério; saúde da mulher; musicoterapia; terapias integrativas

Abstract

Introduction. Menopause is a natural phase in a woman's life, marked by physical and emotional symptoms that affect and compromise quality of life, overall health, interpersonal relationships, and daily activities. Strategies such as music therapy have been explored as integrative care to promote well-being during this period. **Objective.** To examine the application of music therapy as an intervention for relieving symptoms during menopause and climacteric through a literature review. **Method:** Integrative Literature Review using the databases Medline, Lilacs, Cochrane, SciELO, and Google Scholar, covering the period from 2018 to 2025. Studies involving the use of music with women in menopause and climacteric were included, addressing physical, psychological, and cognitive symptoms. **Results.** Of the articles found, six were selected: five used music listening interventions conducted by nursing professionals, and one addressed active and receptive interventions led by a music therapist. The interventions showed positive effects on anxiety, insomnia, and depression. **Conclusion.**

The review confirms that music therapy can be an effective intervention for symptom relief during menopause and climacteric, while also providing a space for support and listening. Music listening conducted by other professionals showed relevant benefits, whereas the music therapist's role expanded therapeutic possibilities by fostering emotional engagement and individual expression. Therefore, the practice proves promising for comprehensive care of women in this phase.

Keywords. Menopause; climacteric; women's health; music therapy; integrative therapies

Resumen

Introducción. La menopausia es una fase natural en la vida de la mujer, caracterizada por síntomas físicos y emocionales que afectan y comprometen la calidad de vida, la salud integral, las relaciones interpersonales y las actividades diarias. Estrategias como la musicoterapia han sido exploradas como forma de cuidado integrador para promover el bienestar en este período.

Objetivo. Verificar la aplicación de la musicoterapia como intervención para aliviar los síntomas en la menopausia y el climaterio mediante una revisión bibliográfica. **Método.** Revisión Integrativa de la Literatura en las bases de datos Medline, Lilacs, Cochrane, SciELO y Google Scholar, con un recorte temporal de 2018 a 2025. Se incluyeron estudios que utilizaron música con mujeres en el climaterio y la menopausia, abordando síntomas físicos, psicológicos y cognitivos. **Resultados.** De los artículos encontrados, se seleccionaron seis: cinco utilizaron intervenciones de escucha musical realizadas por profesionales de enfermería y uno abordó intervenciones activas y receptivas dirigidas por un musicoterapeuta. Las intervenciones mostraron efectos positivos sobre la ansiedad, el insomnio y la depresión. **Conclusión.** La revisión confirma que la musicoterapia puede ser una intervención eficaz para aliviar los síntomas en el climaterio y la menopausia, además de proporcionar un espacio de acogida y escucha en este momento. La escucha musical realizada por otros profesionales mostró beneficios relevantes, mientras que la actuación del musicoterapeuta amplió las posibilidades terapéuticas al favorecer el compromiso emocional y la expresión individual. Por lo tanto, la práctica se muestra prometedora en el cuidado integral de la mujer en esta etapa.

Palabras clave. Menopausia; climaterio; salud de la mujer; musicoterapia; terapias integradoras

Trabalho realizado na Faculdade Santa Marcelina, São Paulo-SP, Brasil.

Conflito de interesse: não

Recebido em: 19/09/2025

Aceito em: 28/22/2025

Endereço para correspondência: Michele Barros de Souza Simões. R. Turiassu 507. Perdizes. São Paulo-SP, Brasil. CEP 05005-001. Email: michelesimoes@usp.br

INTRODUÇÃO

No Brasil, estima-se que aproximadamente vinte e nove milhões de mulheres estejam no período da menopausa, segundo dados oficiais do IBGE (2024)¹. A Organização Mundial da Saúde (OMS) projeta que, até o presente ano (2025)², a menopausa deverá impactar mais de um bilhão de pessoas globalmente. Esses dados são relevantes quando consideramos que a expectativa de vida das mulheres no Brasil é de 80,1 anos (IBGE)³, o que significa que muitas

viverão cerca de um terço de suas vidas no período da menopausa.

Embora a menopausa não seja considerada uma patologia, mas sim uma fase natural da vida das mulheres — assim como a puberdade, a gestação e o puerpério —, ela ainda é pouco estudada e abordada com a devida atenção, principalmente na rede básica de saúde voltada à população feminina⁴. A OMS define a menopausa como a ausência de menstruação por doze meses consecutivos. Antes desse período, é denominada perimenopausa ou climatério, que pode durar anos, caracterizada por oscilações no ciclo menstrual e o aparecimento de diversos sintomas. Esse processo ocorre, em média, em mulheres entre 45 e 55 anos².

Mesmo sendo um período inevitável, a menopausa ainda é cercada de tabus e desinformações, em grande parte devido à escassez de estudos científicos robustos⁵. Essa negligência compromete a qualidade de vida da mulher em uma fase em que ela permanece ativa socialmente — no ambiente familiar, cuidando dos filhos adolescentes e, em alguns casos, dos pais idosos —, bem como no mercado de trabalho, onde muitas ainda são provedoras do lar⁶.

A menopausa requer cuidados específicos e individualizados. As oscilações hormonais que ocorrem ao longo da vida da mulher atingem um verdadeiro "tsunami" no período que antecede a menopausa, impactando profundamente sua qualidade de vida em todos os âmbitos, ocasionando em uma cascata de consequências no período

da senescência⁵.

Dentro do conceito atual de atenção integral à saúde, a musicoterapia pode ser considerada uma prática que promove saúde de forma integrada, contemplando aspectos biopsíquicos e sociais⁷. Dessa forma, o uso da música nesse contexto revela-se adequado para um ciclo de vida complexo, repleto de facetas e individualidades que ainda carecem de maior esclarecimento e estudo.

Desde a Antiguidade, são inúmeros os relatos sobre os benefícios que a música pode oferecer ao ser humano. Porém, foi a partir da Segunda Guerra Mundial (1935-1945), com estudos envolvendo soldados americanos, que se comprovou sua ação terapêutica, inaugurando um caminho de desenvolvimento e estudos específicos da música no cuidado e promoção da saúde⁸.

Ao longo das últimas décadas, pesquisas demonstraram que a utilização da música como elemento terapêutico pode contribuir na redução de sintomas desse período da menopausa, como o nervosismo e ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga, irritabilidade, lapsos de memória, labilidade emocional, dificuldade de concentração, redução de libido, entre outros⁹.

A musicoterapia foi regulamentada como profissão no Brasil em abril de 2024¹⁰, após quatro décadas de mobilização e luta da categoria, trazendo novas perspectivas para sua aplicação de forma institucionalizada. Essa regulamentação permite a ampliação de estudos que fortaleçam esse tipo de intervenção na área da saúde.

Diante da precariedade e a especificidade em relação ao cuidado das mulheres nesta fase, o objetivo desse artigo foi verificar por meio de revisão bibliográfica, a aplicação da musicoterapia como uma possibilidade de intervenção para esse período, com resultados para o alívio e minimização de sintomas frequentes e recorrentes no climatério e menopausa.

MÉTODO

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, realizada nas bases de dados Medline (via PubMed), Lilacs (via BVS), Cochrane, Scielo e *Google Scholar*, de fevereiro a abril de 2025. As palavras-chave utilizadas foram: Música e mulheres, Musicoterapia e menopausa, Música e menopausa. A busca foi direcionada a artigos em inglês e português, publicados entre 2018 e 2025, cujo texto completo estivesse disponível de forma gratuita, que abordassem pesquisas realizadas com mulheres no período da perimenopausa e da menopausa utilizando intervenções com música e musicoterapia. Os artigos foram analisados por meio dos títulos, resumos e pelo conteúdo integral.

Os estudos elegíveis apresentavam a aplicação da música na menopausa como tema central, tendo como discussão os aspectos sobre sintomas urogenitais, neuroendócrinos, cardiovasculares, imunológicos, psicológicos, metabólicos, cognitivos e dermatológicos, bem como a atuação da Atenção Primária à Saúde no suporte às mulheres. Foram excluídos trabalhos duplicados e os que

abordavam apenas a menopausa nos aspectos genéricos com intervenções sem o uso da música.

RESULTADOS

A pesquisa sobre a relação entre música e menopausa revelou uma distribuição variada de estudos nas principais bases de dados científicos.

No PubMed, foram identificados quatro artigos pertinentes ao tema, dos quais apenas um encontra-se disponível na íntegra. Esse estudo destaca especificamente o uso da música no contexto da menopausa, evidenciando sua aplicação como estratégia terapêutica, também encontrado no *Google Scholar*.

Na base Cochrane, a busca inicial retornou vinte e um artigos que abordam aspectos da saúde feminina no climatério. No entanto, ao aplicar filtros específicos para a interseção entre música e menopausa, apenas sete estudos foram identificados, sem acesso integral aos textos.

A base Lilacs apresentou um volume expressivo de publicações, totalizando noventa e quatro estudos sobre a relação entre mulheres e música. Apesar da amplitude dos temas abordados, nenhum artigo trata especificamente da conexão entre menopausa e musicoterapia, o que reforça a carência de pesquisas que aprofundem essa temática no contexto latino-americano.

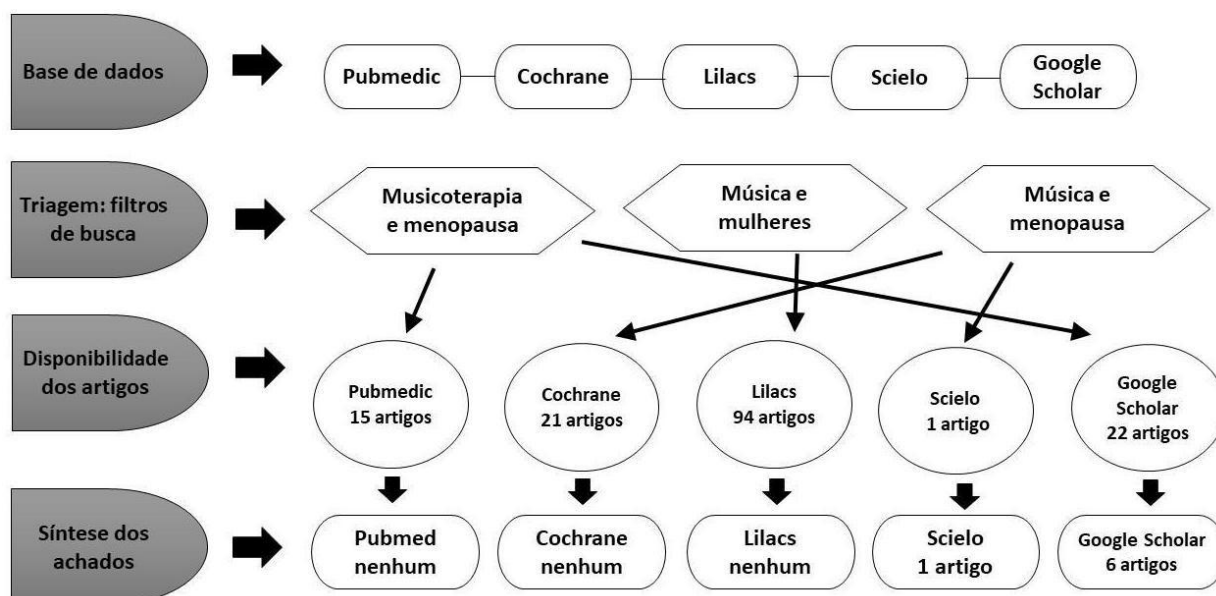
No *Google Scholar*, foram encontrados vinte e dois artigos que discutem aspectos da música e menopausa, sendo que apenas seis deles estão disponíveis na íntegra. A

diversidade de trabalhos identificados sugere um interesse crescente na investigação da influência da música sobre sintomas menopausais, ainda que o acesso a textos completos permaneça limitado.

Por fim, a base SciELO apresentou apenas um artigo repetido do Google Scholar, não acrescentando novas referências exclusivas sobre o tema.

Em resumo, foram selecionados seis artigos^{9,11-15}, um artigo do Brasil (pesquisa manual)⁹, dois da Indonésia^{12,14}, um da Índia¹³, um da Coreia¹⁵ e um da Turquia¹¹. Dentre esses, somente um artigo tratava da musicoterapia propriamente dita, os demais eram da área da enfermagem, que utilizavam a música com o público-alvo.

Figura 1. Fluxograma dos artigos encontrados de acordo com as bases de dados.



A presente revisão abrange seis artigos^{9,11-15}, dos quais cinco utilizaram experiências musicais de escuta como intervenção aplicada por profissionais da enfermagem¹¹⁻¹⁵, enquanto um abordou intervenções ativas e receptivas, conduzidas por musicoterapeutas⁹.

A utilização da escuta musical, predominante na maioria dos estudos analisados, consistiu na audição de músicas previamente selecionadas com o objetivo de promover relaxamento e bem-estar, contribuindo para a minimização dos sintomas do período da menopausa.

A partir da leitura destes artigos, foi possível observar que outros profissionais da área da saúde podem usufruir das potencialidades da música, apesar de não terem a formação em musicoterapia. No entanto, cabe ressaltar que a aplicação da musicoterapia, em sua essência, só é possível por profissional habilitado, conforme estabelece a Lei nº 14.842, de 11 de abril de 2024 (Art. 3º)¹⁰.

A musicoterapia aplicada por um musicoterapeuta habilitado foi citada em apenas um dos estudos⁹, utilizando intervenções musicoterapêuticas que envolvem a participação ativa das pacientes na criação e execução musical, podendo gerar benefícios adicionais relacionados ao engajamento emocional e à expressão individual, com a possibilidade da ressignificação de sintomas e condições específicas.

Tabela 1. Comparativo das metodologias utilizadas nos estudos analisados.

Artigo	Tipo de intervenção	Profissional	Protocolo de intervenção	Período
Deshpande <i>et al.</i> 2024 ¹³ Índia	Escuta musical	Enfermeiro	3 grupos divididos: grupo aeróbico de step, música clássica com fones de ouvido, música clássica e step	2 semanas 3x/semana
Sumaningsih <i>et al.</i> 2023 ¹⁴ Indonésia	Escuta musical	Enfermeiro	3 grupos: Música de Mozart, música espiritual e música de Kitaro ^a por 30 minutos por dia	3 semanas 7x/semana
Ugurlu <i>et al.</i> 2022 ¹¹ Turquia	Escuta musical	Enfermeiro	Makam ^b – 15 minutos manhã e noite – em casa	5 semanas 7x/semana
Sujjantoro <i>et al.</i> 2022 ¹² Indonésia	Escuta musical	Enfermeiro	Relaxamento induzido progressivo com respiração diafragmática, imagens mentais e música com sons da natureza de 20 a 30 minutos	7 dias, 1 vez por dia
Moon <i>et al.</i> 2018 ¹⁵ Coreia do Sul	Escuta musical	Enfermeiro	Música clássica, por 30 minutos antes de dormir, recomendado ouvir 20 vezes cada sessão, em casa	4semanas, 5x/semana
Barcellos <i>et al.</i> 2018 ⁹ Brasil	Modelo clínico bipartite - interativa e receptiva	Musicoterapeuta	Intervenção presencial com músicas escolhidas pelas participantes e pelos musicoterapeutas, conforme o modelo clínico bipartite.	3 meses, 1x/semana

a.Kitaro é o nome artístico de Masanori Takahashi, compositor japonês reconhecido internacionalmente por suas obras no gênero *New Age*. Sua produção musical é marcada por paisagens sonoras contemplativas, que combinam sintetizadores, instrumentos tradicionais orientais e elementos da música eletrônica, resultando em composições instrumentais utilizadas em contextos terapêuticos e meditativos. b.Makam é uma técnica tradicional de improvisação com padrões, alturas e desenvolvimentos próprios, mas sem ritmo fixo. Ele tem origem no maqam árabe e no octoeco bizantino, tem influências de outras tradições musicais turcas.

Dos seis artigos selecionados, cinco são estudos na área da enfermagem¹¹⁻¹⁵, que, mobilizados pela necessidade de intervenções terapêuticas não farmacológicas, investigaram o uso da música.

Nos cinco artigos mencionados¹¹⁻¹⁵, a intervenção musical consistiu na escuta de músicas por meio de fones de ouvido, realizada em ambiente domiciliar. O tempo médio de tratamento variou de sete dias a cinco semanas, com sessões de 15 a 30 minutos, aplicadas de três a cinco vezes por semana.

O artigo realizado na Indonésia¹⁴ dividiu as participantes em três grupos de caráter experimental, nos

quais foram utilizadas músicas de Mozart, música espiritual e composições do músico Kitaro, sem inclusão de grupo controle.

Nos demais cinco artigos, foram utilizadas músicas clássicas instrumentais, repertórios tradicionais locais e canções escolhidas pelas próprias participantes.

Outra pesquisa, também realizada na Indonésia¹², associou à intervenção musical técnicas de relaxamento induzido progressivo com foco na respiração.

Os resultados foram expressivos e positivos quanto à melhora da qualidade de vida, da depressão e da qualidade do sono.

O estudo conduzido na Índia¹³, dividiu os participantes em três grupos: um submetido a exercícios aeróbicos, outro à escuta musical e um terceiro a uma combinação de ambos. Os melhores resultados foram observados no grupo que utilizou exclusivamente a música como intervenção terapêutica.

Dessa seleção de estudos, apenas um artigo foi aplicado, planejado e supervisionado por musicoterapeutas. Observa-se, portanto, a consistência e a propriedade de diversos dispositivos técnicos e metodológicos que justificam as ações, não de forma aleatória, mas de maneira criteriosa e coerente com as demandas específicas do grupo de estudo em questão.

Tabela 2. Efeitos das intervenções musicais em mulheres na menopausa.

Artigo	Estrutura metodológica	Instrumentos de avaliação	Conclusão
Deshpande <i>et al.</i> 2024 ¹³ Índia	3 grupos: Música, step e combinado (step+música)	Escala MENQOL	A intervenção musical isolada apresentou maior eficácia em comparação às demais.
Sumaningsih <i>et al.</i> 2023 ¹⁴ Indonésia	3 grupos: A - Música de Mozart; B - Música espiritual; C - Música de Kitaro	Escala MRS Medição Pressão arterial Peso corporal	Mozart: Melhor efeito na redução da pressão arterial e aumento do peso corporal. Kitaro: Redução da depressão, mas menos eficaz que a música espiritual. Música espiritual: Maior impacto na redução da depressão em comparação com os outros grupos.
Ugurlu <i>et al.</i> 2022 ¹¹ Turquia	Intervenção Controle	Escala: BDI MRS PSQI	A intervenção musical reduziu os sintomas da menopausa e depressão e aumentou a qualidade do sono das mulheres no período da menopausa.
Sujijantoro <i>et al.</i> 2022 ¹² Indonésia	Intervenção Controle	Escala PSQI	A música combinada com sons da natureza e relaxamento guiado aumentou significativamente a qualidade do sono das mulheres no período da menopausa.
Moon <i>et al.</i> 2018 ¹⁵ Coreia do Sul	Intervenção Controle	Escala: DASS-21 e DASS-12	Redução dos sintomas depressivos em mulheres na perimenopausa, além de favorecer melhorias na qualidade de vida.
Barcellos <i>et al.</i> 2018 ⁹ Brasil	Intervenção (9 mulheres)	QOLSF 36 (Teste Autoaplicável de Qualidade de Vida SF 36	Mudança significativa principalmente nos domínios “vitalidade”, com o recrudescimento do cansaço (mais disposição) e, “saúde mental” – menos depressão e mais paz interior.

Dos seis artigos analisados, três realizaram estudos com grupos controle e de intervenção^{11,12,15}, avaliando sintomas da depressão, qualidade de vida, qualidade do sono e outros aspectos relacionados aos sintomas no período da menopausa.

Dois estudos^{13,14} dividiram as participantes em três grupos, sem grupo controle. Apenas um estudo envolveu um único grupo⁹, porém contemplando uma ampla gama de especificidades que poderiam impactar a saúde integral das mulheres nesse período, abrangendo todos os níveis humanos (biopsicossocial-espiritual).

Observa-se que, em todos os estudos, independentemente da abordagem e aplicação, a utilização

da música apresentou resultados superiores, promovendo bem-estar e melhorias na saúde geral em comparação com outras intervenções para esse período.

DISCUSSÃO

Os estudos analisados indicam, que a utilização da música como recurso terapêutico, contribui significativamente para o bem-estar de mulheres no climatério e na menopausa. No entanto, cada abordagem apresenta particularidades que influenciam os resultados e o impacto dessa intervenção. A pesquisa de Barcellos *et al.*⁹, conduzida por musicoterapeutas, revelou melhoras expressivas no estado emocional das participantes, promovendo maior equilíbrio e redução dos sintomas depressivos. Ainda que o domínio 'dor' não tenha apresentado melhora significativa, o estudo destaca que seu escore foi inferior ao observado em outras patologias, sugerindo a influência do estado mental na percepção algica, dado o caráter psicossomático da dor. No domínio 'aspectos emocionais', embora o valor de p tenha se aproximado do nível de significância, os dados sugerem o potencial terapêutico da musicoterapia para esse grupo, ainda que o curto período de intervenção (15 sessões) possa ter limitado efeitos mais amplos. Por outro lado, foram observadas variações significantes nos domínios de saúde mental e vitalidade, indicando que a musicoterapia impactou positivamente o componente mental das participantes, com reflexos físicos como aumento da energia. Esses achados

reforçam a necessidade de estudos mais aprofundados para compreender melhor os efeitos fisiológicos e emocionais da musicoterapia nesse período.

O estudo de Moon *et al.*¹⁵ investigou uma intervenção musical baseada na escuta diária de peças clássicas selecionadas e músicas de preferência pessoal durante quatro semanas, voltada às mulheres na perimenopausa. Os resultados revelaram uma redução significativa nos sintomas depressivos e melhora na qualidade de vida, sugerindo o potencial dessa estratégia como recurso de apoio à saúde mental. Apesar dos efeitos positivos, os autores reconhecem limitações quanto à generalização dos achados, uma vez que o repertório musical foi restrito e a escuta ocorreu exclusivamente antes de dormir. Assim, recomendam-se estudos futuros que explorem diferentes gêneros musicais e variações no momento de aplicação da intervenção, a fim de ampliar a compreensão e aplicabilidade dos efeitos observados.

No estudo de Ugurlu *et al.*¹¹ foram comparadas diversas intervenções não farmacológicas à intervenção musical, incluindo exercícios aeróbicos, *mindfulness*, técnicas respiratórias e relaxamento progressivo. A música se destacou, como a opção mais eficaz para a melhora do humor e da qualidade do sono. No entanto, relatos de baixa adesão ao uso de fones de ouvido, que eram uma prerrogativa da intervenção, apontam um desafio na experiência da escuta musical, algo a ser considerado em possíveis aplicações clínicas.

A pesquisa de Sumaningsih *et al.*¹⁴ explorou diferentes tipos de música, incluindo composições de Mozart, músicas de cunho espiritual e composições do músico Kitaro. Os resultados indicaram que a música de Mozart promoveu relaxamento e aumento de peso, enquanto a música espiritual teve efeitos mais evidentes na redução dos sintomas depressivos. Essa diferença sugere que frequências sonoras específicas podem gerar respostas neurológicas distintas, reforçando a importância da regulação emocional e fisiológica por meio da música. No entanto, o estudo não especificou claramente o tipo de música espiritual utilizada, o que limita a replicabilidade dos achados.

Por sua vez, o estudo de Sujijantoro *et al.*¹² investigou os efeitos de uma intervenção terapêutica combinada de relaxamento muscular progressivo e escuta de sons da natureza em mulheres na menopausa. Os resultados indicaram que essa combinação promoveu um estado de conforto e relaxamento, contribuindo significativamente para a melhora na qualidade do sono. A intervenção, de fácil aplicação, mostrou-se eficaz na redução de distúrbios e sintomas da menopausa e climatério e foi recomendada como uma estratégia viável para ser incorporada na prática de enfermagem em unidades de atenção primária à saúde. Os autores também destacam seu potencial como ferramenta complementar no cuidado integral à mulher nesse período.

Ainda, Deshpande *et al.*¹³ compararam exercícios aeróbicos com a intervenção por escuta musical, concluindo

que a música teve maior efeito na redução do estresse e na promoção do bem-estar. Contudo, a metodologia de seleção das músicas não foi detalhada, o que compromete a precisão dos resultados quanto à eficácia terapêutica dessa abordagem. Tal limitação evidencia a importância de critérios clínicos claros na definição das experiências musicais, levando em conta não apenas aspectos sonoros, mas também suas implicações subjetivas e contextuais para cada indivíduo⁷.

A análise dos resultados evidencia que a utilização da música nos estudos revisados ocorreu majoritariamente por meio da escuta musical, aplicada por profissionais de enfermagem e saúde pública, sem vinculação direta aos métodos clínicos específicos da musicoterapia. Por outro lado, observa-se que intervenções que envolvem participação ativa dos pacientes em experiências musicais — como criação, improvisação ou execução sonora — tendem a ser mais exploradas em contextos conduzidos por musicoterapeutas habilitados, em que há intencionalidade clínica e direcionamento terapêutico.

Estudos como os de Moon *et al.*¹⁵ e Sujijantoro *et al.*¹² evidenciaram que a música, dentro de um protocolo de relaxamento, funciona como um recurso secundário, sem seguir uma estrutura metodológica específica de musicoterapia.

Outro aspecto notável é a forma como os estudos abordam a aplicação da música como terapia sem a presença de um musicoterapeuta, exceto Barcellos *et al.*⁹.

De modo geral, os estudos analisados apontam para uma aceitação crescente da música como um recurso terapêutico na menopausa, mas ainda há desafios metodológicos a serem superados.

Pesquisas sobre o cérebro feminino, mostram que o climatério deve ser entendido como um processo dinâmico e multifatorial e não apenas como uma fase de declínio hormonal⁵. A percepção negativa predominante sobre esse período pode influenciar a maneira como os estudos são estruturados e, conseqüentemente, os resultados obtidos.

Podemos enfatizar ainda, que a musicoterapia por sua vez, vai além da simples utilização da música como ferramenta de bem-estar. Ela destaca a música como um processo terapêutico ativo, fundamentado em técnicas específicas para atender às necessidades individuais dos pacientes. Isso significa que, diferentemente da escuta musical casual ou da aplicação genérica de músicas relaxantes, a musicoterapia estrutura a experiência sonora com objetivos clínicos definidos, como regulação emocional, estímulo neurológico e integração social¹⁶.

Na área da saúde, a musicoterapia se diferencia por ser uma modalidade baseada em intervenção especializada, empregando princípios da psicologia, neurologia e terapia ocupacional¹⁷. Os musicoterapeutas utilizam métodos como improvisação, recriação, composição e escuta receptiva, aplicados dentro de uma relação terapêutica musical, com o objetivo de promover mudanças na saúde física, emocional, cognitiva e social dos pacientes⁷. Portanto, enquanto a

música pode ser um recurso terapêutico por si só, a musicoterapia reforça a necessidade de uma intervenção qualificada e individualizada¹⁸.

Por fim, a compreensão de que esse período da vida deve ser visto como uma fase de transformação e adaptação neurológica torna-se essencial, exigindo abordagens terapêuticas que integrem conhecimento científico e suporte profissional. Entende-se como sendo urgente a necessidade de fortalecer e ampliar o acesso à musicoterapia nos serviços de saúde básica, garantindo que essa prática seja reconhecida não apenas como uma estratégia complementar, mas como uma intervenção especializada fundamentada cientificamente¹⁹. Além disso, a construção de uma rede estruturada de apoio — por meio de espaços públicos de cuidado e orientação — que valorize o impacto positivo da musicoterapia, reforça a necessidade de discutir a menopausa como uma questão coletiva de saúde, e não apenas como um desafio individual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados demonstram que a música pode ser um recurso terapêutico quando conduzidos de forma fundamentada e sistematizada para alcançar resultados clínicos específicos.

De acordo com os artigos analisados, ficou reconhecido que a música tem propriedades que afetam aspectos emocionais, cognitivos e fisiológicos, mas do ponto de vista da musicoterapia é importante ressaltar que seu uso

terapêutico deve ser conduzido de maneira estruturada e planejada, dentro de um contexto clínico e sob a supervisão de musicoterapeutas.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163>
2. World Health Organization (WHO). Menopause. Geneva: WHO; 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause/>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tábuas completas de mortalidade 2023. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3097/tcmb_2023.pdf
4. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf
5. Mosconi L. O cérebro e a menopausa: a nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa. São Paulo: HarperCollins; 2024.
6. Wajnman S, Jesus JC. A geração sanduíche no Brasil: desafios e impactos do cuidado intergeracional. RELAP 2016;10:23-45. <https://doi.org/10.31406/relap2016.v10.i1.n18.2>
7. Bruscia KE. Defining music therapy. 3rd ed. Gilsum: Barcelona Publishers; 2014.
8. LEÃO, Eliseth Ribeiro (Org.). *Cuidar de pessoas e música: uma visão multiprofissional*. São Caetano do Sul: Editora Yendis, 2009. Pg.192-199.
9. Barcellos LRM, Imbrosi T, Ribas YM. A musicoterapia aplicada no período do climatério/menopausa. In: Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Musicoterapia; 2017; Rio de Janeiro. UBAM; 2017. Disponível em: [Anais completos do XVI Simpósio Brasileiro de Musicoterapia – UBAM](#)
10. Brasil. Lei nº 14.842, de 11 de abril de 2024. Regulamenta a profissão de musicoterapeuta. Diário Oficial da União; 2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14842.htm
11. Ugurlu N, Vural Şahin M, Oktem OH. The effect of receptive music therapy on sleep quality and depression in menopausal women: a randomized controlled trial. Rev Assoc Med Bras 2024;70:e20230829. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20230829>
12. Sujijantoro AC, Anggraini R, Afyah RK. The Effect of Combination Of Progressive Muscle Relaxation And Nature Sound Music Therapy

- On Sleep Quality Of Menopausal Women. *J App Nurs Health* 2022;4:340-8. <https://doi.org/10.55018/janh.v4i2.107>
13. Shruti D, Chaitanya AK, Om CW, Waqar MN, Pratik P, Sakshi PA. A Community Survey on Effect of Step Aerobic Exercises and Music Therapy on Mental Health in Menopausal Women. *J Med P'ceutical Allied Sci* 2021;10:3300-3. <https://doi.org/10.22270/jmpas.V10I4.1306>
14. Sumaningsih R, Ngestiningrum AH, Rahayu TP, Kasih AM. The effect of Mozart's music, Kitaro instruments, and spiritual music on menopausal depression. *Malaysian J Med Health Sci* 2024;20(Suppl9):181-5. <https://doi.org/10.47836/mjmhs20.s9.30>
15. Moon H, JungJang H. Effect of the music therapy for peri-menopausal women. Seoul: Universidade Nacional da Coreia do Sul; 2019. <https://doi.org/10.21742/ijcpp.2018.2.1.01>
16. Cunha R. Musicoterapia: uma prática clínica. Anais da Associação de Musicoterapia do Paraná. 2007. <https://amtpr.com.br/wp-content/uploads/2021/03/2007-5.-Musicoterapia-uma-pratica-clinica..pdf>
17. Tavares MCH. A influência da neurociência cognitiva sobre a musicoterapia: bases para a musicoterapia neurológica. *RCS CEUMA* 2023;1:8-28. <https://doi.org/10.61695/rcs.v1i1.1>
18. Gattino GS. Musicoterapia e Autismo: teoria e prática. São Paulo: Memnon Edições Científicas; 2011.
19. Thaut MH, Hoemberg V (eds). Handbook of neurologic music therapy. Oxford: Oxford University Press; 2014.